

24/09/2025

Se (re)toucher pour se (re) lier

Une innovation au service des
femmes isolées

Document de projet en réponse à l'appel à projet du fond de dotation Lyon
Habitat Métropole



PAR



audrey relandeau

2 MAINS DE FEMMES – 2mainsdefemmes@gmail.com

I. Résumé exécutif

« **Se (re)toucher pour se (re)lier : une innovation au service des femmes¹ isolées** » est un projet porté par l'association **2mains de femmes**, visant à lutter contre **l'isolement corporel et social** des femmes, isolées, en particulier celles vivant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) de la métropole lyonnaise. Par le biais de parcours d'accompagnement corporel et d'ateliers collectifs, l'association propose une approche innovante centrée sur **le toucher relationnel**, levier de santé mentale, de reconnexion à soi et aux autres, et de construction de liens sociaux plus apaisés et égalitaires.

Le projet cible prioritairement les femmes en situation de précarité, isolées et souvent peu visibles dans les dispositifs d'accompagnement classiques. En partenariat avec les centres sociaux, les conciergeries sociales et les associations locales implantées dans les QPV, **2mains de femmes** mobilise une méthodologie participative et inclusive afin de renforcer le pouvoir d'agir de ces femmes.

II. Diagnostic local et pertinence du projet

1. Un enjeu reconnu : l'isolement social

En France, plus de **7 millions de personnes** (+15 ans) souffrent d'isolement relationnel, soit **11 % de la population**, et **20 %** déclarent se sentir régulièrement seules. La pandémie a aggravé cette situation, avec un impact fort sur la **santé mentale** : anxiété, dépression, troubles du sommeil, baisse de l'estime de soi. Ces phénomènes sont désormais identifiés comme un problème majeur de santé publique.

2. Un impensé : l'isolement corporel

Mais un pan essentiel de cette réalité reste absent des politiques sociales et sanitaires : **l'isolement corporel**. Celui-ci se définit par l'absence récurrente de toucher bienveillant ou, au contraire, par la présence de touchers uniquement toxiques ou intrusifs. Pourtant, le toucher relationnel – **non médical, non sexuel, non violent** – est un besoin humain vital. Il apaise, rassure, structure l'identité et soutient la confiance dans les autres. L'exemple du **peau-à-peau en maternité**, qui a réduit de moitié la mortalité des bébés prématurés, montre son importance dans le développement et la survie. Les

¹ Par « femme » est désignée toute personne se reconnaissant du genre féminin.

adultes, eux aussi, ont besoin de se sentir touchés et de toucher, pour se sentir vivants et visibles.

Certaines études post-Covid ont montré que l'absence de ce toucher relationnel aggrave durablement la fragilité psychique et sociale : anxiété, troubles de l'humeur, retrait relationnel. Il se crée un **cercle vicieux** : le mal-être corporel nourrit l'isolement social, et l'isolement social renforce la coupure avec son propre corps.

3. Une réalité à Lyon

À Lyon, la vulnérabilité des femmes face à cet impensé est particulièrement visible :

- **Femmes SDF** : elles représentent **40 %** de la population sans-abri, mais les dispositifs restent pensés pour un public masculin. Seules **2 structures** proposent des hébergements d'urgence prioritairement aux femmes isolées, et **1 accueil de jour non mixte** existe (« Au Tambour ! »). Les femmes concernées sont donc largement invisibilisées dans les dispositifs classiques.
- **Violences faites aux femmes** : plus de **1 200 plaintes** pour violences et **800 appels** pour violences domestiques ont été enregistrés à Lyon en 2021–2022. Ces violences corporelles peuvent générer une déconnexion à son corps et une méfiance dans le toucher des autres, ainsi qu'une perte durable de confiance en soi et en autrui, et empêchent la reconstruction de liens sociaux apaisés.
- **Travailleuses du sexe** : environ **1 400 femmes** sont concernées à Lyon. Les associations de terrain alertent sur leur isolement croissant, les violences subies et la dissociation entre leur corps et leurs émotions.
- **Femmes handicapées, âgées isolées ou malades chroniques** : ces profils représentent une proportion importante de la population locale et cumulent des vulnérabilités liées à la stigmatisation de leur corps, souvent réduit au médical ou au soin.

À ces situations s'ajoutent celles des **femmes vivant en QPV**, qui peuvent croiser ces vulnérabilités en plus de leur vulnérabilité économique. Elles sont confrontées à des ruptures de liens dans leurs parcours personnels et professionnels, qui les isolent d'autant plus.

4. Offre existante et limites

Le tissu lyonnais est riche en associations travaillant sur le logement, la santé, l'accès aux droits ou la lutte contre les violences. Mais la **dimension corporelle** de l'isolement reste largement absente :

- Les dispositifs sociaux prennent peu en compte la question de la **reconnexion au corps et aux autres par le toucher**.
- Les activités de **socio-esthétique** ou de bien-être existantes agissent surtout sur l'**image de soi**, mais rarement sur le lien sensoriel et relationnel.
- Le **massage bien-être est assez élitiste**, peu accessible à toutes que ce soit financièrement ou culturellement.
- et la **câlinothérapie** inexistante dans le paysage social lyonnais.

Ces lacunes empêchent de traiter en profondeur l'impact de l'isolement corporel sur la santé mentale et les liens sociaux.

5. Pourquoi le projet est pertinent et innovant

Ainsi, ce projet souhaite répondre à un **impensé social** : il met en lumière l'isolement corporel comme facteur clé de mal-être, d'exclusion sociale et de marginalisation, et propose d'y répondre par une approche intégrée.

- **Pertinence** : en ciblant les femmes les plus vulnérables (SDF, victimes de violences, travailleuses du sexe, incarcérées, âgées ou handicapées), dont celles en QPV, le projet vient combler un manque évident des dispositifs actuels.
- **Innovation** : il introduit la dimension corporelle – le toucher relationnel et la tendresse – comme **outil d'accompagnement** dans des parcours où prédominent aujourd'hui les approches sociales, médicales et administratives.
- **Impact** : en restaurant la sécurité corporelle, le projet contribue à améliorer la santé mentale, à permettre une **réappropriation du corps** et, surtout, à favoriser la **reconnexion à l'autre et aux autres corps**. Cette reconnexion ouvre la voie à des **liens sociaux plus apaisés et égalitaires**, conditions indispensables d'une inclusion durable.

II. Objectifs, résultats attendus et indicateurs du projet

1. Les objectifs généraux

Objectif général 1 : Un plus grand nombre de femmes ont une relation positive à leur corps et entretiennent des relations corporelles et sociales apaisées et équilibrées

Objectif général 2 : Le toucher relationnel et la tendresse sont reconnus et adoptés comme vecteurs de liens sociaux.

2. L'objectif spécifique

En partenariat avec des associations locales basée sur la Métropole de Lyon, l'association 2mains de femmes a confirmé la pertinence et a suivi les effets de ses parcours d'accompagnement corporel sur la santé (physique et mentale) et les relations corporelles et sociales des femmes isolées, en particulier de celles habitant dans les QPV de la métropole.

3. Les résultats attendus et indicateurs

- ❖ **Résultat attendu 1 – RA 1** : L'association *2mains de femmes* s'est fait connaître auprès des acteurs locaux, dont ceux intervenant au sein des QPV, et auprès des femmes elles-mêmes, pour co-identifier des nouveaux partenaires et participantes au projet, et les mettre en réseau autour de la place des corps dans le prendre soin et le travail social.

Indicateurs R1 :

- ☐ A 3 mois de projet, l'association a réalisé au moins **5 visites terrain** dans les QPV de la ville pour identifier des femmes pouvant être concernées par le projet ;
- ☐ A 6 mois, au moins 4 nouvelles conventions de partenariats sont signées avec un acteur local ;
- ☐ A la fin du projet, au moins **20 professionnel.les** de la santé et de l'action sociale se sont rencontrés autour de la question de la place des corps et de la tendresse dans le prendre soin et le travail social.

- ❖ **Résultat attendu 2 – RA 2** : Les parcours d'accompagnement corporel sont réalisés auprès de femmes isolées corporellement, en particulier celles vivant en QPV, en respect des protocoles prédéfinis.

Indicateurs R2 :

- ☐ A 6 mois de projet 2026, l'association est mieux équipée pour réaliser les parcours d'accompagnement corporel ;
- ☐ A la fin du projet, au moins 3 protocoles de parcours d'accompagnement corporel sont formalisés, en fonction des besoins et profils des femmes à accompagner ;
- ☐ A la fin du projet, au moins **100 femmes**, dont 50% venant des QPV, ont participé à un parcours d'accompagnement corporel ou aux ateliers collectifs.

- ❖ **Résultat attendu 3 – RA 3** : Les effets et la qualité des protocoles d'accompagnement corporel sont évalués, formalisés et diffusés, en les désagrégeant par âge, handicap et situation de vie des femmes accompagnées

Indicateurs R3 :

- ☐ A 4 mois de projet, une méthodologie de suivi des effets et satisfaction est créée et mise en place en collaboration avec les associations partenaires du projet et les femmes concernées.
- ☐ A fin de projet, les équipes partenaires ont intégré systématiquement un temps d'évaluation des parcours (effets et satisfaction) dans leurs processus de suivi/évaluation de leurs usagères ayant participé au projet, et ces temps donnent lieu à des restitutions auprès de *2mains de femmes*.
- ☐ A fin de projet, au moins 3 réunions d'échanges sur la qualité et effets des parcours d'accompagnement corporel sont animés entre les associations partenaires, des participantes et l'association *2mains de femmes*.

III. Publics cibles, bénéficiaires finaux et parties prenantes du projet

1. Publics cibles et bénéficiaires finaux

Les femmes isolées corporellement constituent les bénéficiaires directs du projet. Elles vivent en situation de précarité ou d'exclusion, et plus particulièrement dans les **quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)**.

Les profils des **bénéficiaires directes** incluent :

- **Femmes sans domicile fixe ou mal logées**, souvent invisibilisées dans l'offre sociale et contraintes à l'hypervigilance ;
- **Survivantes de violences** physiques, sexuelles ou psychologiques, pour qui le toucher est associé à la douleur ou au danger ;
- **Femmes handicapées ou en rémission de maladie chronique**, fréquemment réduites à un corps médicalisé ou stigmatisé ;
- **Travailleuses du sexe**, dont les corps sont utilisés mais rarement valorisés dans leur besoin de tendresse et de lien ;
- **Femmes âgées isolées** et **femmes incarcérées**, privées d'interactions affectives régulières ;

Bénéficiaires indirects :

- **Les enfants et familles des femmes accompagnées**, qui bénéficient de relations plus apaisées et sécurisées lorsque la mère retrouve confiance en son corps et dans ses liens.
- **Les professionnel·les de la santé et de l'action sociale** formés/sensibilisés à la place des corps et de la tendresse dans le prendre soin, qui enrichissent leurs pratiques et améliorent la qualité de l'accompagnement.

2. Parties prenantes locales

La réussite du projet repose sur un écosystème de **partenaires associatifs et institutionnels** déjà implantés dans les quartiers lyonnais et de la métropole:

- **7 services d'associations déjà partenaires** de 2mains de femmes : L'Eclaircie, SALVA et Olympe de l'association LE MAS, ALPIL, Un Chez Soi d'Abord Lyon, Le site des grandes voisines du Foyer Notre Dame des Sans Abris, avec qui consolider les protocoles et identifier et accompagner des femmes concernées.
- **Les centres sociaux et associations de quartier**, en première ligne pour accueillir les femmes des QPV et les orienter vers le projet.
- **Les conciergeries sociales**, relais de proximité permettant de repérer et mobiliser des femmes isolées dans les résidences HLM.
- Autres **associations de l'action sociale** luttant contre la précarité dans la métropole, qui participeront à l'identification de femmes concernées et au réseau de professionnels sensibilisés.

3. Institutions et acteurs publics associés

Le projet s'inscrit en complémentarité avec les politiques locales et pourra mobiliser :

- **Les mairies d'arrondissement et la Ville de Lyon**, qui portent une responsabilité forte en matière d'inclusion et de lutte contre l'isolement social.
- **Les bailleurs sociaux implantés en QPV**, directement concernés par la qualité de vie et la cohésion sociale de leurs locataires. En facilitant l'identification des femmes isolées, ils contribuent à leur repérage et trouvent dans ce projet un levier concret pour remplir leur mission sociale.
- **Les services de la Métropole**, compétents en matière d'insertion et de lutte contre les exclusions, qui trouveront dans ce projet une réponse innovante aux besoins non couverts par les dispositifs existants.

4. Valeur ajoutée de l'implication des parties prenantes

L'articulation du projet avec ces différents acteurs garantit :

- une **meilleure identification** des femmes concernées dans les QPV et les résidences HLM,
- une **complémentarité** avec les services déjà proposés (logement, insertion, accès aux droits, santé),
- une **appropriation collective** de la thématique de l'isolement corporel, afin que ce besoin encore impensé trouve progressivement sa place dans les pratiques professionnelles et les politiques publiques.

IV. Durée, durabilité et impact du projet

1. Durée du projet

Le projet est prévu sur **12 mois** à compter de la date de signature du contrat

2. Durabilité et impact du projet

La durabilité du projet repose sur les changements durables qu'il génère à la fois chez les femmes participantes et dans leur environnement social et institutionnel. À moyen terme, les parcours corporels et ateliers collectifs permettent une amélioration tangible de la santé mentale des femmes concernées, en réduisant leur isolement et en renforçant leur confiance en elles. Ces effets dépassent la sphère individuelle pour se traduire dans leurs relations familiales et amicales, favorisant une meilleure communication, une plus grande sérénité et un sentiment de soutien mutuel. En retrouvant un rapport apaisé à leur corps et une capacité à se relier aux autres, les femmes voient leur pouvoir d'agir renforcé, ce qui pourrait les engager davantage dans la vie sociale et associative de leur quartier.

La diffusion d'un guide de bonnes pratiques et la sensibilisation des partenaires associatifs et médico-sociaux aux enjeux du toucher relationnel garantissent également un impact plus large et pérenne : les structures impliquées intègrent progressivement ces approches dans leurs pratiques, influençant la qualité de leurs accompagnements bien au-delà de la durée du projet.

Enfin, en s'appuyant sur des collaborations solides avec les associations de proximité, le projet crée une dynamique collective qui inscrit la lutte contre l'isolement corporel et social dans une perspective de long terme, contribuant à transformer les modes d'accompagnement au bénéfice de l'ensemble des habitantes des quartiers prioritaires.

V. Méthodologie et détails des activités

1. Méthodologie

La méthodologie du projet repose sur trois principes clés, qui garantissent à la fois l'ancrage local, la pertinence des actions pour les femmes accompagnées et la qualité globale du dispositif.

❖ Une démarche “d’aller vers” fondée sur le partenariat

Le projet ne se déploie pas en vase clos : il s'appuie sur un réseau d'acteurs déjà implantés dans les quartiers et auprès des publics cibles. Les **centres sociaux, associations de quartier, CHRS, conciergeries sociales, maisons des femmes, associations spécialisées dans les QPV** deviennent des partenaires actifs.

- Concrètement, des **visites terrain régulières** sont réalisées pour repérer et rencontrer les femmes isolées corporellement.
- Cette démarche d'aller vers permet de **lever les freins à la participation** (manque de confiance, absence d'information, difficultés de mobilité).
- Elle favorise également une **complémentarité** avec les services déjà proposés par les structures partenaires (hébergement, insertion, santé, accompagnement social).
- Aucun lieu n'est créé. Le projet va chercher à mutualiser des espaces déjà existants.

❖ Une approche personnalisée et participative des parcours d'accompagnement corporel

Schéma d'une séance type (30 -45 min)

● Question d'intro :
« Comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui ? »

● Respiration / cohérence cardiaque
→ S'ancrer dans l'instant

● Activités adaptées selon réponses et envies :
- Auto-massage
- Massage bien-être (partie du corps)
- Jeu tactile dans le dos (avec/sans vêtement, avec/sans outil)
- Étreintes assises ou debout

● Fin de séance et sortie :
Moment de tendresse, respiration finale et remise en dynamique du corps

Un parcours se définit par une récurrence hebdomadaire d'au moins 4 séances, et peut aller d'un mois (4 séances) à 6 mois (24 séances).

Chaque parcours corporel est conçu de façon **personnalisée** pour répondre aux besoins spécifiques de chaque femmes (traumatismes, rapport au corps, histoire de vie). C'est pourquoi au moins 3 protocoles seront consolidés pour répondre aux « grands » enjeux de chaque groupe de femmes, tout en restant adaptables à chaque situation.

- Les contenus des séances sont **adaptés aux envies** des participantes, en respectant leur consentement, leur rythme et leur choix.
- Les ateliers collectifs favorisent l'**expression, la confiance et la sororité** entre femmes, dans un cadre sécurisé.
- L'approche est participative : les participantes sont invitées à **donner leur avis, ajuster les modalités** et devenir actrices de leur propre cheminement.

Cette méthodologie vise à laisser le temps à chaque femme de se reconnecter à soi, sans pression, sans injonction et sans objectif autre que d'être là. Le nombre de séances par parcours est défini avec la femme concernée, et varie entre 4 (1 séance par semaine)

❖ Une approche inclusive et une démarche qualité participative

Toutes les activités sont conçues pour être **inclusives et accessibles** :

- Accessibilité physique et sensorielle pour les **femmes handicapées** (adaptation des lieux, supports, postures).
- Prise en compte des **discriminations multiples** (migrantes, femmes précaires, travailleuses du sexe, femmes âgées, incarcérées) afin de créer des espaces réellement accueillants et sécurisés.

L'ensemble du projet suit une **démarche qualité participative** :

- des **temps d'évaluation réguliers** sont organisés avec les bénéficiaires et les partenaires,
- les retours sont utilisés pour **ajuster en continu** les activités,
- une **capitalisation** des apprentissages est partagée pour nourrir les pratiques locales et le plaidoyer.

2. Détails des activités

Résultat 1 :

(R1.1) Identification des acteurs présents et intervenants dans les QPV et collecte des informations sur les habitants de ces QPV pour préparer les visites à domicile; **(R1.2)** Réalisation de Visite terrain de ces acteurs et de visite à domicile de foyer ayant au moins une femme ; **(R1.3)** Elaboration de la liste des participantes au projet, via de nouveaux partenariats ou suite aux visites à domiciles ; **(R1.4)** Organisation et coanimation de 2 conférences – débats sur la place des corps dans le prendre soin, en collaboration avec le groupe « prendre soin » géré par *ma friche urbaine*.

L'équipe projet ira à la rencontre d'acteurs locaux, en particulier ceux présents et travaillant avec des femmes vulnérables dans les QPV, pour présenter le projet et identifier conjointement des femmes qui pourraient être concernées. Des temps de rencontres- informations collectives seront proposés pour lancer des synergies entre acteurs autour du projet et de la question de l'isolement corporel des femmes vulnérables. Des nouvelles associations/structures partenaires seront identifiées et des conventions de partenariat seront signées. Celles-ci s'engageront à mettre à disposition leurs locaux et au moins 2 professionnel.le.s de leur équipe au service de ce projet et du suivi des femmes concernées par celui -ci. En complément, pour identifier des femmes non connues par les associations locales, quelques visites à domicile, avec l'appui des représentants des quartiers et des bailleurs sociaux, seront

faites pour informer au plus près les femmes habitantes des QPV de ce projet et les inviter à y participer. Une première liste de femmes sera ainsi consolidée dans les 3 premiers mois du projet. De nouvelles visites et entrées dans le projet pourront se faire tout au long du projet, selon demandes et disponibilité de l'équipe projet. 2 conférences- débats entre professionnel.le.s, institutions, bailleurs sociaux et femmes concernées seront organisées pour discuter de la place des corps dans les pratiques professionnelles et la prise en compte des femmes isolées.

Résultat 2

(R2.1) Achat du matériel facilitant la réalisation des parcours d'accompagnement corporel; **(R2.2)** Recrutement et formations de nouvelles intervenantes bénévoles **(R2.3)** Consolidation des protocoles des parcours d'accompagnement (contenus attendus des séances individuelles et ateliers collectifs, récurrence, lieu....) ; **(R2.4)** Réalisation des parcours d'accompagnement corporel et ateliers collectifs ; **(R2.5)** Suivi des femmes participantes pour assurer leur participation aux séances proposées dans les parcours.

Selon les espaces mis à disposition par les associations/structures partenaires du projet, de nouveaux matériels pour les parcours seront achetés (ex : paravents, charriot de portage, caisse de rangement, chaise/table de massage, des tapis de sol, serviettes, plaids, coussins, diffuseur d'huile..) et le stock d'huile de massage sera fait. Sur base des réalisations déjà en cours avec d'autres partenaires, et en concertation avec les nouveaux partenaires, 3 protocoles de parcours d'accompagnement seront proposés, pour répondre aux enjeux de groupes « type » de femmes (femmes violentées, femmes handicapées, femmes SDF par ex) et pour s'adapter aux contraintes des associations partenaires. Ces protocoles seront expérimentés durant tout le projet et revus au moins 2 fois, dans le respect d'une démarche qualité, avec les professionnel.le.s et les femmes concernées elles- mêmes. Au moins 4 nouvelles intervenantes bénévoles – des femmes pour toucher des femmes, avec la possibilité de faire appel à un intervenant homme si l'enjeu du toucher se situe autour de cette question de genre - seront recrutées et formées par des experts externes sur les enjeux du toucher relationnel, des situations de vie des publics cibles du projet, sur la « bonne » posture d'accompagnement et sur comment animer une séance individuelle et un atelier collectif d'accompagnement corporel. Les parcours seront proposés et animés sur la base d'une demi-journée par partenaire local ou par quartier d'habitation des femmes, si les associations n'ont pas les espaces disponibles pour accueillir ces activités hebdomadaires ou si les femmes ne sont pas suivies par une association. Des engagements de présence seront pris avec chaque femme entrant dans un parcours, qui pourrait donner lieu à l'annulation de sa participation si absences récurrentes non

justifiées. Tous les 3 mois un atelier collectif réunissant toutes les femmes suivies dans chaque association sera organisé pour renforcer les liens sociaux entre les femmes. Les professionnels de chaque association et l'équipe projet feront des points de briefing et debriefing réguliers, au moins une fois par mois, pour suivre conjointement l'évolution des femmes participantes au projet. Et l'équipe projet facilitera le référencement de femmes participantes non suivies par une association, vers une association cohérente par rapport à sa situation.

Résultat 3

(R3.1) Elaboration de la méthodologie d'évaluation des effets et de la satisfaction des parcours d'accompagnement corporel, et de ses outils (questionnaires, observations, entretiens...); **(R3.2)** Réalisation des temps d'évaluation et suivi individuels ; **(R3.3)** Animation d'au moins 3 réunions d'échanges entre l'équipe projet, les associations partenaires et des participantes sur la qualité et satisfaction des parcours ; **(R3.4)** Analyse et consolidation des résultats dans un rapport de suivi des effets et satisfaction, dont une partie sur des bonnes pratiques à diffuser et recueil de témoignages des usagères ; **(R3.5)** Coordination et suivi du projet et relations avec les partenaires et les autorités locales.

Un processus d'évaluation des effets des parcours sur la santé mentale et les liens sociaux des femmes sera conçu, en collaboration avec les équipes professionnelles des associations partenaires et un questionnaire de satisfaction sera monté avec les femmes concernées et les équipes professionnelles. Dans le respect d'une démarche qualité, le processus intégrera au moins 3 étapes d'analyse, en amont du parcours, à mi-parcours et en fin de parcours, pour pouvoir comparer les évolutions éventuelles. En complément de ce processus individuel, 3 temps d'échanges entre l'équipe projet, les professionnel.les et des femmes participantes seront animés autour de la pertinence, intérêt et effets des parcours d'accompagnement, et de leur complémentarité avec les autres activités d'accompagnement des associations partenaires. Des membres de la famille/ami.e.s des femmes participantes y seront aussi conviés pour avoir un regard plus extérieur des éventuels effets sur les relations sociales des femmes participantes. L'ensemble de ces informations/données récoltées en individuel ou en collectifs seront analysés pour en ressortir des bonnes pratiques et points d'attentions qui seront consolidés dans un guide de bonnes pratiques. Ce guide sera simple, clair et accessible autant aux professionnel.les qu'aux participantes et institutionnelle et ne fera pas plus de 10 pages. Ce guide et les résultats du projet seront diffusés lors d'un atelier de clôture du projet, en présence de tous les partenaires et parties prenantes de celui-ci. Enfin, tout au long du projet, l'équipe projet s'assurera de la bonne gestion de celui-ci, dans le respect des indicateurs et échéances, ainsi que de la qualité de communication et collaboration avec les partenaires et parties prenantes.

3. Le cadre logique et chronogramme des activités

❖ Le cadre logique se trouve en **annexe 7**.

❖ Le chronogramme des activités

Activités relevant du financement demandé	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12
1.1 Identification des acteurs présents et intervenants dans les QPV et collecte des informations sur les habitants de ces QPV pour préparer les visites à domicile												
1.2 Réalisation de Visite terrain de ces acteurs et de visite à domicile de foyer ayant au moins une femme ;												
1.3 Elaboration de la liste des participantes au projet été signature de nouveaux partenariats												
1.4 Organisation et coanimation de 2 conférences – débats												
2.1 Achat de matériel facilitant la réalisation des parcours d'accompagnement ;												
2.2 Consolidation des protocoles des parcours d'accompagnement (contenus attendus des séances individuelles et ateliers collectifs, récurrence, lieu....)												
2.3 Réalisation des parcours d'accompagnement corporel et ateliers collectifs												
2.4 Suivi des femmes participantes pour assurer leur participation récurrente et implication.												
3.1 Elaboration de la méthodologie d'évaluation des effets et de la satisfaction des parcours d'accompagnement corporel, et de ses outils (questionnaires, observations, entretiens...)												
3.2 Réalisation des temps d'évaluation et suivi individuels;												
3.3 Animation d'au moins 3 réunion d'échanges entre le réseau des intervenantes, les associations partenaires et des participantes sur la qualité et satisfaction des parcours ;												
3.4 Analyse et consolidation des résultats dans un rapport d'évaluation, dont une partie sur des bonnes pratiques à diffuser et recueil de témoignages des usagères ;												
3.5 Coordination et suivi du projet et relations avec les partenaires et les autorités locales												

VI. Ressources humaines et financière du projet

1. L'équipe Projet

L'équipe Projet se compose :

❖ Equipe salariée

- **1 coordinatrice de projet** salariée – 8 mois - qui aura la responsabilité de la gestion du projet et d'une partie des interventions auprès des femmes participantes et professionnel.le (séances individuelles, ateliers collectifs, réunions collectifs, conférences) – *équivalent 65% de la réalisation des activités.*

❖ Equipe bénévoles

- Un réseau d'intervenantes bénévoles qui auront la responsabilité de réaliser en partie les activités d'interventions directes auprès des femmes participantes, et de coanimer les conférences, en fonction de leurs disponibilité – *équivalent 35% de la réalisation des activités*

❖ Expertises en consultance

- 1 expert formation des bénévoles sur le toucher relationnel – 5 jours
- 1 expert Suivi/évaluation – 15 jours

2. Le Budget du projet

Le budget total du projet est de **48 870 €**.

Thème	Sous-catégorie	Unité	Quantité	Cout unitaire (€)	Montant (€)
Personnel chargé					26 400
	Coordination	Mois	4	3300	13 200
	Intervention	Mois	4	3300	13 200
Achats					15 000
	Prestations de services	Jours	20	500	10 000
	Matériel pédagogique	Q	1	1000	1000
	Matériel Activités	Q	1	4000	4000
Autres logistique activités					4500
	Frais de déplacement	an	1	2000	2000
	Frais de bouche	an	1	1500	1500
	Locations salles	Q	10	100	1000
Fonctionnement					2970
	télécommunication	mois	12	20	240
	Location bureau	an	1	1600	1600
	Assurance	an	1	130	130
	Fournitures	Q	1	1000	1000
TOTAL					48 870

Le financement sollicité auprès du Fonds de dotation de Lyon Habitat Métropole est de **12 000 euros**.

Il viendra compléter les co-financements et auto-financement de l'association.

ANNEXES

Annexe 1 : Fiche de structure

Annexe 2 : JOAFE – récépissé de création de l'association

Annexe 3 : Dernière composition du CA

Annexe 4 : Logo 2mains de femmes

Annexe 5 : Leaflet de communication de l'association

Annexe 6 : Statuts signés 2 mains de femmes

Annexe 7 : Cadre logique du projet présenté

Annexe 8 : RIB de l'association

Annexe 9 : Attestation sur l'honneur de non-assujettissement à la TVA